

„Nie wiem” — *i to jest OK*

Każde sprawdzanie obiecuje pewność, której nigdy nie da. Pewność to iluzja. Akceptacja niepewności to jedyne wyjście.

CZAS: ciągła praktyka Przy sprawdzaniu, „just right”, lęku o zdrowie

ŹRÓDŁO: Dugas i wsp. (1998); Tolin i wsp. (2003); Hezel i McNally (2016); Grayson (2014, *Freedom from OCD*)

JAK UŻYWAĆ

Zmień pytanie z „czy jestem PEWNY/-a?” na „**czy mogę TOLEROWAĆ niepewność?**”. Celowo pozostaw coś niesprawdzonego (jeden zamek). Toleruj dyskomfort. **Perspektywa ACT:** „mogę żyć z niepewnością — wszyscy żyją, ja po prostu jestem tego bardziej świadomy/-a”. Jedyna droga do spokoju: akceptacja, że NIGDY nie będziesz w 100% pewny/-a.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Nietolerancja niepewności (ang. *intolerance of uncertainty*, IU) to **potrzeba 100% pewności** co do bezpieczeństwa. Dugas i wsp. (1998): IU jest *transdiagnostycznym czynnikiem* — najpierw opisana w GAD, potem w OCD. Jedna z 6 domen OCCWG. Tolin i wsp. (2003): **rozdziela OCD od innych zaburzeń lękowych** — pacjent z OCD nie toleruje samej *niepewności*, nie tylko zagrożenia. Kompulsja daje *iluzję 100% pewności*. Im bardziej szukasz pewności, tym **mniej** ją masz — kompulsja mówi mózgowi „to było niebezpieczne, sprawdź jeszcze raz”. Hezel i McNally (2016): IU jest **predyktorem** przewlekłości OCD. Grayson (2014): „OCD obiecuje pewność, ale nigdy jej nie dostarcza”.

01 ? Pewność to iluzja — paradoks szukania

PUŁAPKA PEWNOŚCI

„Muszę WIEDZIEĆ, czy żelazo jest wyłączone”.

Sprawdzasz raz → ulga 30 sek → „a może źle widziałem?” → sprawdzasz znowu → ulga 20 sek → „a może w międzyczasie się włączyło?”

Im więcej sprawdzasz, tym mniej jesteś pewny/-a. Mózg uczy się: „sprawdzanie potrzebne”.

WYJŚCIE — TOLERANCJA

„Sprawdziłem/-am raz. Może być wyłączone, może nie. Idę dalej”.

Toleruj impuls do sprawdzania (zauważ, nie reaguj). Po kilku minutach impuls opada.

Mózg uczy się: „niepewność jest do wytrzymania — bezpieczeństwo nie wymaga 100% pewności”.

02 ? Wszyscy żyją z niepewnością

Codzienna niepewność, którą tolerujemy bez sprawdzania:

„Czy mój samolot dziś nie spadnie?” — **nie wiesz, ale wsiadasz.**

„Czy ten kierowca nie jest pijany?” — **nie wiesz, ale przechodzisz przez ulicę.**

„Czy moje dziecko nie ma raka?” — **nie wiesz, ale nie robisz codziennych badań.**

„Czy ta restauracja nie zatruje mnie dziś?” — **nie wiesz, ale jesz.**

Klucz: tolerancja niepewności to *nie* umiejętność, którą ludzie bez OCD **mają** — to umiejętność, której *nie zauważają*. Ty masz tę samą zdolność. Po prostu Twój mózg **kieruje uwagę** na niepewność w innych obszarach. To można zmienić.

03 Ćwiczenie — celowo zostaw coś niepewne

SYTUACJA, W KTÓREJ ZWYKLE SZUKAM PEWNOŚCI

— konkretna

ILE RAZY ZWYKLE SPRAWDZAM

— liczba

CO ZROBIĘ TYM RAZEM — CELOWO MNIEJ

— np. 1× zamiast 10×

POZWOLENIE SOBIE NA NIEPEWNOŚĆ

— formuła

DZIEŃ	SUDS NA POCZĄTKU	SUDS PO 15 MIN	CO SIĘ NAUCZYŁEM/-AM
1			
2			
3			
4			
5			

04 Cztery formuły do codziennego użytku

MOŻE BYĆ, MOŻE NIE

„Może drzwi są zamknięte, może nie. **Idę dalej.**”
Zastępuje „muszę wiedzieć” akceptacją obu możliwości.

PEWNOŚCI NIE MA

„Nigdy nie będę pewny/-a w 100%. **To dotyczy każdego.**”
Normalizuje niepewność jako uniwersalne doświadczenie.

TOLERANCJA, NIE ELIMINACJA

„Nie próbuję usunąć niepewności. **Próbuję ją wytrzymać.**”
Zmiana celu z „pewność” na „akceptacja”.

EKSPOZYCJA NA „NIE WIEM”

„Czuję się nieprzyjemnie. **To w porządku.**”
Nieprzyjemność mija.”
Toleruj uczucie niepewności jak każdą inną emocję.

Klucz: Grayson (2014, *Freedom from OCD*): „OCD to nie zaburzenie lękowe — to zaburzenie nietolerancji niepewności. Lęk jest tylko sygnałem, że nie potrafisz wytrzymać „nie wiem””. Cała terapia ERP można **przeformułować** jako ekspozycję na niepewność, nie na zagrożenie. Każde „nie sprawdzę, nie umyję, nie zapytam” to ekspozycja na „nie wiem na pewno”. Hezel i McNally (2016): redukcja IU jest **silniejszym predyktorem** długoterminowej poprawy w OCD niż samo zmniejszenie objawów. Łącz z powstrzymaniem reakcji i akceptacją z ACT.